Station 1

Du är AT läkare och arbetar på akuten. Du kallas till akutrummet där en 60 årig man inkommit med ambulans efter att ha svimmat under besök på stadens bibliotek. Ambulanspersonalen uppmäter lågt blodtryck och allmäntillståndet är påverkat, och man önskar din hjälp.

Din uppgift blir att ta anamnes och föreslå fortsatt utredning och behandling.

Station 2

Du är på akuten.

Patienten du träffar har sökt hälsocentralen pga. tilltagande trötthet under några veckors tid. U-stickan som togs via HC visar

Blod: ++
Protein: +++
Leukocyter: neg
Ketoner: neg
Nitrit: neg
Glukos: neg

Blodtrycket är 220/110 mmHg

Blodprover är tagna, men du har inga resultat. Du skall göra en fysisk **status** med inriktning på fynd som skulle kunna leda dig vidare i behandling eller diagnostik vid akut njursvikt.

Gör dina statusmoment och berätta högt vad du är efter.

Station 3

På denna station möter du en patient som bokats in på din mottagning på vårdcentralen för årlig kontroll av riskfaktorer efter genomgången hjärtinfarkt för 2 år sedan.
Din uppgift är:

1. Att komplettera anamnesen på ett relevant sätt
2. Är att göra en bedömning av patientens riskfaktorer och läkemedelsbehandling.
3. Att informera patienten om din bedömning samt föreslå eventuella åtgärder. Du ska också besvara patientens frågor.

Klinisk undersökning, dvs status, ingår inte i uppgiften. Längre motiverande samtal för ev. förändring av levnadsvanor ingår inte i uppgiften.

Patienten är 52 år gammal, för 2 år sedan drabbades patienten av en mindre hjärtinfarkt (NSTEMI) och genomgick PCI med revaskularisering. Efter insjuknandet mått bra, inga symtom. Behandlar med Candesartan 8 mg, Metoprolol 25mg, Atorvastatin 40 mg, Trombyl 75 mg.
Svar på provtagning för en vecka sedan:
Blodstatus, kreatinin, Na, K u.a. fP-glukos u.a, P-kolesterol 3,1, LDL 1.3. Normalt vilo-EKG. BMI 26.
Blodtryck på mottagningen: 125/75, puls 56

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 4

Patient med anemi.

På din öppenvårdsmottagning söker en 34-årig tidigare frisk kvinna för trötthet.

Blodstatus visar Hb 78, MCV 76, MCHC 296, RDW 16, LPK 6.0 och TPK 250.

Uppgiften är värdera patientens symptom och fastställa sannolik orsak till anemin samt föreslå ett bekräftande laboratorieprov. Därefter ge lämplig ordination med adekvat instruktion till patienten inklusive uppföljning.

Normalvärden:

Hb 134-170 g/L, MCV 82-98 fL, MCHC 317-357 g/L, RDW 12.3-14.3 %

LPK 3.5-8.8 10E9/L, TPK 145-348 10E9/L

Station 5

Du träffar en patient på hälsocentralen med misstänkt astma. Spirometri är normal utan signifikant reversibilitet.

Misstanken om astma kvarstår, nästa steg i diagnostiken blir att göra en PEF-kurva med symtomregistrering (2-3 veckor)

Du ska:

- **Förklara varför patienten ska göra en PEF-kurva**
- **Instruera hur man blåser PEF**
- **Be patienten blåsa PEF**
- **Instruera patienten hur man ska fylla i en PEF-kurva**

Anamnestagande ingår inte.

Station 6

Du arbetar på en vårdcentral. Patienten 72 år söker för problem med magen. Du ska ta en anamnes och föreslå initial utredning för patienten.

Station 8

Du arbetar som AT läkare på akuten. Du ombeds undersöka en ung patient som inkommer på grund av hjärtrusningar och snabb puls. Din uppgift blir att:

1. ta en **riktad anamnes** med fokus på hjärtrusning (en utförlig livstilsanamnes ingår inte i uppgiften)
2. bedöma eventuella **akuta undersökningar**
3. föreslå **akut behandling/handläggning**.

Station 9

En 61 år patient kommer till dig på hälsocentralen på grund av minnesproblem sedan ett halvår tillbaka. Besvären har kommit smygande och ökar långsamt. Har svenska som modersmål, arbetar som mattelärare och äter inga läkemedel.

Din roll:

Distriktsläkare på hälsocentral

Du ska:

- Utföra minnestestet MMSE-SR enligt protokoll inne på rummet, endast de markerade frågorna.
- Ange i rätt ruta patientens poäng utifrån dennes svar, avseende fråga 1-5, 11-13 samt 19.
- Meddela patienten totalpoäng och din tolkning av resultatet, samt om fortsatt utredning är nödvändig eller ej

Station 10

En 67-årig patient söker hälsocentralen på grund av ansträngningsutlöst dyspné som har tilltagit under det senaste halvåret. Patienten har aldrig rökt, är normalviktig och tidigare frisk.

Hen har gjort en dynamisk spirometri.

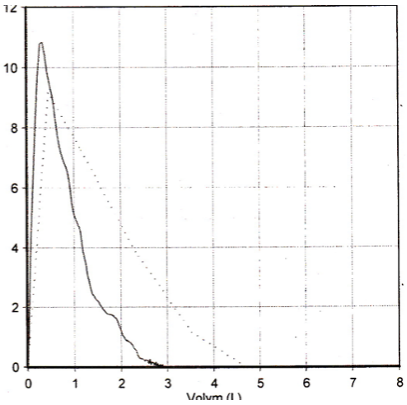
Du ska:

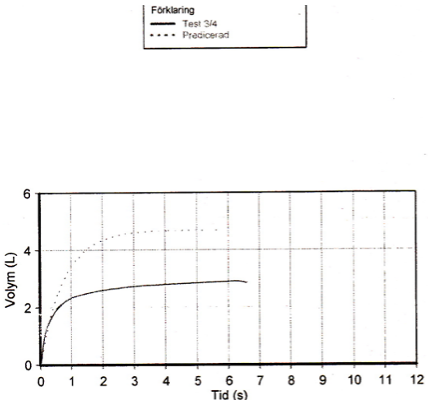
- **Tolka spirometrin och informera bedömaren om din tolkning, med medicinsk terminologi.**
- **Förklara sedan din tolkning, och vad det innebär, för patienten.**
- **Tycker du att fyndet motiverar någon ytterligare utredning? I så fall, varför, och med vilken/vilka undersökningar? Informera patienten!**

DU BEHÖVER INTE TA NÅGON YTTERLIGARE ANAMNES ELLER UNDERSÖKA PATIENTEN

Station 10 – inne på rummet

Parameter	Enhet	Test		Predikterat värde	Referens-område
		Bästa	% Pred		
FVC	L	2.85	66	4.69	3.67 – 5.71
FEV_1	L	2.33	65	3.44	2.19 – 4.69
FEV_1/FVC		0.82			0.63 –0.83





Station 11

En 42-årig patient har utretts på grund av smärtor i höger flank på din vårdcentral. Datortomografi av buken visar inte någon högersidig gallsten eller njursten men en 2 x 2 cm stor homogen, välavgränsad tumör i vänster binjure med utseende som ett godartat binjurebarkadenom.

Patienten är nu symtomfri och kommer till dig för besked om fynd på datortomografi.

Du ska:

- **Mäta patientens blodtryck**
- **Informera patienten om fyndet på datortomografi, blodtryck och blodprov**
- **Informera om eventuell fortsatt utredning**

Station 11 – inne på rummet

En 42-årig patient har utretts på grund av smärtor i höger flank på din vårdcentral. Datortomografi av buken visar inte någon högersidig gallsten eller njursten men en 2 x 2 cm stor homogen, välavgränsad tumör i vänster binjure med utseende som ett godartat binjurebarkadenom.

Patienten är nu symtomfri och kommer till dig för besked om fynd på datortomografi.

Laboratorievärden (referensvärden inom parentes):

P-Na 143 mmol/L (137–145), P-K 3,4 mmol/L (3,5–4,4)

Du ska:

- **Mäta patientens blodtryck**
- **Informera patienten om fyndet på datortomografi, blodtryck och blodprov**
- **Informera om eventuell fortsatt utredning**

Station 12

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Station 14

Du är läkare på en strokeavdelning och ska morgonronda en patient. Patienten är 66 år och är sedan tidigare frisk, inga läkemedel. Slutat röka för 3 år sen.

Sökte igår kväll på grund av övergående svaghet höger arm och ben och blev då inlagd.

DT-hjärna samt EKG vid inläggning var utan anmärkning. Har bedömts som TIA och blev insatt på T. Trombyl 75 mg x 1.

Sjuksköterska rapporterar på sittrond att patienten mår bra och känner sig återställd.

Vitalparametrar samt svar på aktuella laboratorieprover finns inne på rummet.

Du ska:

Genomföra rond med patienten inklusive föreslå vidare handläggning

Du ska INTE ta ytterligare anamnes avseende livsstil eller genomföra status.

Station 14 – inne på rummet

Parametrar som finns tillgängliga inne på rummet:

Vitalparametrar

NIHSS: 0 poäng

Puls, 70 slag/min

Blodtryck: 175/100 mmHg

Laboratorieprover (referensvärden)

Hb: 140 g/L (117-153)

Kreatinin: 75 umol/L (50-90)

Kolesterol: 5,9 mmol/L (3,9-7,8)

LDL-C: 3.4 mmol/L (2,0-5,3)

HbA1c: 35 mol/mol (31-46)